

CAPÍTULO 14.13

Lupus Cutáneo Subagudo y Crónico

PERFIL EUNACOM 1.05.1.001
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **Lupus Eritematoso Cutáneo** es una manifestación de la autoinmunidad que afecta primordialmente la piel. Puede presentarse de forma aislada (lupus cutáneo primario) o ser una de las múltiples manifestaciones de un **Lupus Eritematoso Sistémico (LES)**. Se clasifica clásicamente en tres tipos según su evolución y profundidad: agudo, subagudo y crónico.

Lupus Cutáneo Crónico (Lupus Discoide)

El **Lupus Discoide** es la variante más frecuente del lupus cutáneo crónico. Es fundamental reconocerlo por su potencial destructivo y estético.

Cuadro Clínico

Se caracteriza por la aparición de **placas eritematosas** bien delimitadas. Su evolución natural sigue un patrón específico: - **Localización:** Predominantemente en **zonas fotoexpuestas** (cara, pabellones auriculares, escote). - **Involución:** Las placas no desaparecen sin dejar rastro; al sanar, dejan cambios residuales significativos: - Hipopigmentación o hiperpigmentación. - **Cicatrización** (atrofia cutánea).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Cuando el lupus discoide afecta el **cuero cabelludo**, produce una **alopecia cicatricial**. A diferencia de otros tipos de caída de cabello, en este caso el folículo se destruye, por lo que el pelo **no vuelve a crecer** de manera permanente.

Lupus Cutáneo Subagudo

Esta variante tiene una presentación clínica distinta, a menudo relacionada con marcadores serológicos específicos y una alta fotosensibilidad.

- **Morfología:** Suele presentarse como lesiones **anulares** (en forma de anillo) o policíclicas.
- **Características:** El centro de la lesión suele estar más claro (hipopigmentado) o con aspecto de "piel sana", mientras el borde es eritematoso y descamativo.
- **Evolución:** A diferencia del lupus discoide, el subagudo **no suele dejar cicatriz**, aunque sí puede dejar cambios pigmentarios transitorios.

NOTA CLÍNICA

El lupus cutáneo subagudo tiene una fuerte asociación con los anticuerpos **Anti-Ro (SSA)** y **Anti-La (SSB)**, los mismos marcadores que se estudian en el **Síndrome de Sjögren**.

Lupus Cutáneo Agudo

Es la manifestación cutánea más estrechamente ligada a la actividad del **Lupus Eritematoso Sistémico (LES)**.

- **Clínica clásica:** La "**mariposa lúpica**" (eritema malar). Es un eritema que cruza el puente nasal y las mejillas, respetando habitualmente los surcos nasogenianos.
- **Contexto:** Su presencia suele indicar un brote de la enfermedad sistémica.

Diagnóstico y Marcadores

El diagnóstico del lupus cutáneo es eminentemente **clínico**, basado en la morfología de las lesiones y su distribución.

TABLA 14.13.1: TIPO DE LUPUS CUTÁNEO VS LESIÓN CARACTERÍSTICA

TIPO DE LUPUS CUTÁNEO	LESIÓN CARACTERÍSTICA	¿DEJA CICATRIZ?	ASOCIACIÓN SISTÉMICA
Crónico (Discoide)	Placas eritematosas descamativas	Sí (y alopecia)	Baja (5-10%)
Subagudo	Lesiones anulares / psoriasiformes	No (solo manchas)	Moderada
Agudo	Eritema malar (mariposa)	No	Muy Alta

Estudio Complementario

Ante un paciente con lesiones de lupus cutáneo, el paso más importante es **descartar compromiso sistémico**. Se deben solicitar: 1. **Anticuerpos Antinucleares (ANA):** Generalmente positivos en el agudo, menos frecuentes en el discoide puro. 2. **Anti-Ro y Anti-La:** Especialmente en la variante subaguda. 3. **Evaluación de otros órganos:** Hemograma, función renal y sedimento urinario para descartar nefropatía lúpica.

Manejo y Tratamiento

El tratamiento tiene como objetivos controlar las lesiones activas, prevenir las cicatrices (especialmente en el discoide) y evitar las recurrencias.

1. Medidas Generales (Educación)

La **fotoprotección** es el pilar fundamental. Dado que la exposición solar es el gatillante más importante: - Uso estricto de protector solar de amplio espectro. - Ropa protectora y evitar horas de máxima radiación.

2. Tratamiento Tópico

Es la primera línea para formas localizadas: - **Corticoides tópicos:** De alta potencia en el cuerpo o potencia media/baja en la cara. Suelen lograr la involución de las placas.

3. Tratamiento Sistémico

Se reserva para casos severos, resistentes al tratamiento tópico o cuando hay compromiso sistémico asociado: - **Hidroxicloroquina:** Es el fármaco de elección (antimalárico). Ayuda a estabilizar la enfermedad y reduce la fotosensibilidad. - **Corticoides orales:** Se utilizan en dosis moderadas para controlar brotes agudos o formas muy extensas de lupus subagudo/crónico.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, recuerda que ante cualquier lesión sugerente de lupus cutáneo, la conducta inicial siempre incluye la **educación sobre fotoprotección** y el **descarte de compromiso de órganos internos (LES)**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente con placas eritematosas en cara y cuero cabelludo que dejan alopecia cicatricial. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Lupus Cutáneo Subagudo y Crónico. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Lupus cutáneo crónico (discoide): placas eritematosas en zonas fotoexpuestas que dejan cicatriz o cambios de pigmentación
- Alopecia cicatricial permanente cuando afecta cuero cabelludo
- Marcadores: anti-Ro y anti-La
- Tratamiento base: corticoides tópicos + protección solar
- Siempre descartar LES de base
- Casos severos: hidroxiclороquina + corticoides orales

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (LUPUS CUTÁNEO SUBAGUDO Y CRÓNICO)**PREGUNTA 1**

Paciente con placas eritematosas en cara y cuero cabelludo que dejan alopecia cicatricial. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Psoriasis
- B)** Lupus cutáneo crónico (discoide)
- C)** Dermatomiositis
- D)** Rosácea
- E)** Dermatitis seborreica

PREGUNTA 2

¿Cuál es la conducta más importante ante un diagnóstico de lupus cutáneo subagudo o crónico?

- A)** Iniciar metotrexato inmediatamente
- B)** Descartar que sea manifestación de un lupus eritematoso sistémico
- C)** Solicitar biopsia renal
- D)** Iniciar rituximab
- E)** Solicitar ANCA

RESUMEN: LUPUS CUTÁNEO SUBAGUDO Y CRÓNICO

El lupus cutáneo crónico incluye variantes como el lupus discoide. Se presenta con placas eritematosas en zonas fotoexpuestas que involucionan dejando hipopigmentación, hiperpigmentación o cicatriz. Cuando afecta el cuero cabelludo, deja alopecia cicatricial permanente. El diagnóstico es clínico. Los marcadores asociados son anti-Ro y anti-La (los mismos del síndrome de Sjögren). El tratamiento base son corticoides tópicos más educación sobre protección solar. Es fundamental descartar que no sea manifestación de un lupus eritematoso sistémico. En casos severos se maneja con hidroxiclороquina más corticoides orales. El lupus cutáneo agudo (eritema malar/mariposa lúpica) se ve en el LES. El subagudo puede verse como lesiones anulares con centro hipopigmentado.